甲状腺疾病 ★★★（1~5题）

甲亢外科治疗（2010、2017、2018）

- 禁忌症：青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全
- ①原发性甲亢首选全切、近全切
  ②高功能腺瘤首选患侧叶或部分切
- 术前用药
  “别合成、别释放、别来刺激我心脏”
  - 原发性甲亢：先用抗甲状腺药、后加用碘剂 2 周“抗甲状腺药把甲状腺搞大了、通过碘剂给它擦屁股”
    继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药
  - β-R 阻断剂

甲状腺癌

超声，穿刺（确诊），ECT（怀疑骨转移）

乳头状癌	滤泡癌	髓样癌	未分化癌
最常见（2021） 局部淋巴结转移较早、但预后最好（2018）	早期易血道转移	来源于滤泡旁细胞（APUD，2024）	早期易局部和远处转移
乳头中心砂粒体 / 钙化小体、毛玻璃样核、核沟	与滤泡瘤鉴别（生物学行为）——浸润生长 侵犯包膜 发生转移	淀粉样变性 分泌降钙素致低钙血症（2021） 分泌 5-HT 等致类癌综合征（腹泻、面部潮红、多汗）	预后最差

- ＜55 岁的分化型（乳头状癌、滤泡癌）—— 任何 TNM0 为Ⅰ期，任何 TNM1 为Ⅱ期

治疗

- 未分化癌：外放疗（2026）
- 髓样癌：双侧全切、或患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切
- 分化型（2026）
  - 切除范围（2014、2020、2025）——①多数：双侧全切、或患侧叶全切 + 峡部 + 对侧叶近全切
    ②全满足（＜ 1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型）：患侧叶全切 + 峡部
  - 清扫淋巴结——①中央区 / Ⅵ淋巴结需清扫
    ②侧方淋巴结：阴性不清扫、阳性需清扫
  - 术后
    - 甲状腺素预防甲减、防止复发（2008、2013、2016、2019）
    - 放射碘内放疗
    - 甲状腺球蛋白 TG 检测早期复发